EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓ – PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	El cáncer de cuello uterino es el cuarto en frecuencia entre el sexo femenino en el mundo (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022); aunado a ello, datos estadísticos indican que en el año 2020 se reportaron 604 127 nuevos casos y una mortalidad de 341 831 personas a nivel mundial (Sung et al., 2021). En Costa Rica, las últimas estadísticas del Ministerio de Salud con respecto al cáncer colocaron al cervicouterino en tercer lugar en incidencia y en cuarto lugar en mortalidad (Ministerio de Salud [MINSA], 2019), lo cual resulta similar a los datos estadísticos mundiales del 2020. En Costa Rica para este tipo de cáncer se encuentra en el decreto ejecutivo Nº 44261-S, el cual expone las “Norma Nacional para el Manejo del Cáncer cervicouterino en los servicios de salud” siendo la población blanco toda mujer de 20 años y más y sexualmente activa; la frecuencia del tamizaje según grupo de edad y estado de inmunocompetencia es como a continuación: • 20 a 29 años e inmunocompetentes: se realiza citología convencional o de base líquida cada dos años • 30 años o más e inmunocompetentes: se realiza prueba VPH cada cinco años • 20 a 24 años e inmunocomprometidas: se realiza citología convencional o de base líquida cada dos años • 25 años y más e inmunocomprometidas: se realiza prueba VPH cada tres años Para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esta intervención se realiza por medio de Papanicolaou o Test de Virus de Papiloma Humano (VPH); este último todavía no se encuentra generalizado para todos los establecimientos quedando pendiente a setiembre 2025 solamente las Redes Integradas de Prestación de Salud Central Norte y Huetar Atlántica.
Evidencia	A pesar de lo anterior, este tipo de cáncer tiene gran oportunidad de ser prevenible, diagnosticado en fases tempranas y, por ende, tener un tratamiento eficaz con una resolución satisfactoria; incluso, “podría convertirse en el primer cáncer en ser eliminado” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2022). La frase anterior tiene como base la Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicouterino como un problema de salud pública (en inglés); en donde los principales procesos para lograr ese objetivo son: vacunación, tamizaje y tratamiento preventivo, lo cual llevaría a reducir la incidencia a menos de cuatro casos por cada 100 000 mujeres (OMS, 2020).
Consideraciones de Implementación	<u>Barreras:</u> En la parte asistencial, referente al sexo del personal que realiza la consulta, ya que, si el colaborador es hombre, la posibilidad de que la paciente se realice el tamizaje disminuye. Por otra parte, al incorporar en los sistemas se incluyen bajo el mismo código CIE-10 (como diagnóstico de consulta) o CIE-9 (como procedimiento), lo que imposibilita al 2023 la separación entre papanicolaou, test de VPH o si el tamizaje fue realizado en forma privada

	Referente a la incorporación del tamizaje por prueba VPH, se puede sufrir desabastecimiento de los insumos lo que imposibilitaría realizar esta prueba. Estrategias: Se han vistos varias estrategias exitosas como: participación de personal femenino para la toma de la muestra de estos tamizajes en el EBAIS, en fechas específicas. También se ha visto éxito con la implementación de ferias de salud. El "Cubo Citologías Salud" incorpora la variable "Tipo solicitud citológica" que permite separar entre "vaginal" (papanicolaou) y "molecular" (test de VPH), sin embargo, a la setiembre 2025 todavía se encuentran casos incorporados como realización de este tamizaje que no se encuentran en este cubo. En lo referente al desabastecimiento de insumos para realizar prueba VPH se tiene como plan de contingencia el realizar prueba de citología a la paciente, siendo la respuesta para no perder la oportunidad de tamizaje.
Normativa Técnica	• Lineamiento en mejora de la prevención y detección del cáncer de cérvix (2014). • Norma Nacional para el Manejo del Cáncer Cervicouterino en los Servicios de Salud (Decreto Ejecutivo N° 44261-S)
Costo / Efectividad	Las pruebas de tamizaje para cáncer de cuello de útero con mayor costo-efectividad son: Papanicolaou y VPH, ya que requieren menos cantidad de visitas a los centros de salud, siendo la segunda la de mayor costo-efectividad. Ambas pruebas son realizadas por la CCSS y son parte del numerador de los indicadores asociados a esta intervención.
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar la cobertura de tamizaje de cáncer de cuello uterino realizada en el primer nivel por la CCSS en mujeres de 20 a 64 años; de forma institucional, por red integrada de prestación de servicios de salud y área de salud, para contribuir a mejorar las estrategias de acceso y oportunidad
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cómo evolucionan los porcentajes de cobertura del tamizaje con citología cérvico-vaginal en comparación con los resultados obtenidos durante los años de pandemia por Covid-19? ¿Cuál es la diferencia entre áreas de salud respecto al porcentaje de realización de tamizaje de cáncer de cuello uterino a las mujeres que consultan en el primer nivel? ¿Cuál el avance en la implementación de la prueba de VPH por áreas de salud y por RIPSS?
Indicadores asociados a la intervención	09-01-2.0 Cobertura bienal de tamizaje con citología cérvico-vaginal por PAP en mujeres de 20 a 29 años. 09-02-3.0 Cobertura quinquenal del tamizaje de cáncer cervicouterino por medio de prueba VPH o citología convencional en mujeres de 30 a 64 años.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Ministerio de Salud [MINSA]. (2019). Análisis de incidencia y mortalidad por cáncer. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/estadisticas-y-bases-de-

datos/estadisticas-y-bases-de-datos-vigilancia-de-la-salud/estadisticas-vigilancia-de-la-salud/estadistica-de-cancer-registro-nacional-tumores

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (5 de enero de 2022). El cáncer cervicouterino es prevenible, la OMS llama hacer historia eliminándolo. https://news.un.org/es/story/2022/01/1502202

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (20 de enero de 2022). Cáncer Cervicouterino.https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (17 de noviembre de 2020). Por un futuro sin cáncer del cuello uterino: por primera vez el mundo se ha comprometido a eliminar un cáncer. https://www.paho.org/es/noticias/17-11-2020-por-futuro-sin-cancer-cuellouterino-por-primera-vez-mundo-se-ha-comprometido

Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: a cancer journal for clinicians, 71(3), 209–249. https://doi.org/10.3322/caac.21660